

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ



Κεφάλαιο εμπνευσμένο από την άσβεστη, σεπτή μνήμη
της αγαπημένης φίλης Έφης Ζαρκαδούλια,
που είχε ορίσει την ανακούφιση του ψυχικά ασθενούς ως πυξίδα στη ζωή της.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΥΣΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ)

Γενικά: Μία κρίση σωματομετατροπής (υστερική κρίση) μπορεί να υποδυθεί τα πάντα, από οξεία τύφλωση, έμφραγμα μυοκαρδίου έως και εγκεφαλική αιμορραγία και συχνότατα παρουσιάζεται σαν κρίση απώλειας συνείδησης, με ή χωρίς τονικοκλονικούς σπασμούς.

Για αυτόν το λόγο, η διάγνωση μιας υστερικής κρίσεως, ακόμα και σε γνωστό «υστερικό άτομο», τίθεται μόνον με αποκλεισμό άλλων αιτίων ή παθήσεων τις οποίες μιμείται.

Κλινική εικόνα: Οι ασθενείς (γυναίκες/άνδρες: 3/1) εμφανίζονται με ένα ή περισσότερα **σωματικά συμπτώματα** λόγω της υπερδιέγερσης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος - ΑΝΣ (εφίδρωση, ξηροστομία, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, αίσθημα παλμών, τρόμο, ζάλη), καθώς και με **ψυχολογικά συμπτώματα** (έντονο άγχος, πόνος στο θώρακα, αίσθημα δύσπνοιας, αίσθημα αποπροσωποποίησης, αίσθημα επέλευσης τρέλας, έντονος φόβος θανάτου κ.ά.) και βρίσκονται είτε σε έντονη ψυχοσωματική διέγερση, είτε σε κατατονία ή stupor, συχνά μη ανταποκρινόμενοι σε εξωτερικά ερεθίσματα (ακόμη κι επώδυνα) και παραγγέλματα. Τα συμπτώματα κορυφώνονται εντός 10-20 λεπτών και διαρκούν περίπου 1-2 ώρες.

Ιστορικό: Ερευνούμε τι προκάλεσε πιθανώς την κρίση. Συχνά αναφέρονται επανειλημμένα επεισόδια παρόμοιων κρίσεων. Συνήθως, οι κρίσεις εκλύονται από συναισθηματικό stress, αγχογόνο συμβάν, αίσθημα φόβου, κόπωση και αρκετά συχνά παρουσία τρίτων προσώπων. Δέον είναι, να αποκλείουμε το ενδεχόμενο λήψης φαρμάκων ή απότομης διακοπής τους.

Διαφορική διάγνωση: Καρδιακές αρρυθμίες, οξεία καρδιακή ισχαιμία, οξεία εγκεφαλική ισχαιμία ή αιμορραγία (ΑΕΕ), υποξία/υπερκαπνία, θυρεοτοξίκωση, επιληψία, λήψη ουσιών, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Μυασθένεια, διαταραχές νωτιαίου σωλήνα, σύνδρομο Stendhal κ.ά.

► **Αδρή διαφορική διάγνωση υστερίας από κόμα αγνώστου αιτιολογίας:** Με τον ασθενή σε ύπτια θέση, υψώνεται το άνω άκρο και έπειτα αφήνεται να πέσει με κατεύθυνση προς το πρόσωπο του ασθενούς. Στην «υστερία», το άκρο πέφτει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χτυπήσει το πρόσωπο του ασθενούς. Εάν όμως υπάρχει σοβαρή οργανική πάθηση ο ασθενής δεν αυτοπροστατεύεται και το ανυψωθέν άκρο πέφτει χτυπώντας τον ασθενή στο πρόσωπο.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης, ελέγχουμε αρχικά τα A-B-C-D-E του ασθενούς. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T °C) και διενεργούμε αδρή νευρολογική εκτίμηση. Εκτελούμε ΗΚΓ ή επί ενδείξεων θέτουμε τον ασθενή σε συνεχές monitoring.
2. Συζητούμε το παρόν πρόβλημα με τον ασθενή μας και τον υποστηρίζουμε ψυχολογικά.
3. Τοποθετούμε μια μικρή σακούλα γύρω από το στόμα και τη μύτη του ασθενούς και τον προτρέπει να αναπνέει αργά και ήπια μέσα σε αυτή. Έτσι, σταδιακά, μειώνουμε τον υπεραερισμό/αλκάλωση και τα συνεπακόλουθα συμπτώματα (π.χ. τετανία, αιμοδιές).
4. Για ήπιες εκδηλώσεις και σε ασθενείς που βελτιώνονται γρήγορα, χορηγούμε:
 - 1 tab. Alprazolam (Xanax) 0,25 mg ή 0,5 mg (per os), ή
 - 1 tab. Bromazepam (Lexotanil) 1,5 mg ή 3 mg ή 1 tab. Lorazepam (Tavor) 1 mg, (po).
5. Σπανίως, για σοβαρές εκδηλώσεις, δηλ. για βαριά κι εμμένουσα κατάσταση, χορηγείται:
 - 1 amp. Diazepam (Stedon) 10 mg (iv εντός 100 ml NaCl 0,9% ή ενδομυϊκά-im).

Προσοχή: η χορήγηση Διαζεπάμης μπορεί να προκαλέσει παράδοξη, διεγερτική αντίδραση.

Αγωγή κατ'οίκον:

Συχνά, η βραχυχρόνια χρήση αγχολυτικών φαρμάκων μπορεί να κριθεί απαραίτητη, ήτοι:

- tab. Lorazepam (Tavor) 1 mg, 1x3 (po), για 10-15 ημέρες (με αποκλιμάκωση της δόσης).
- tab. Buspirone (Bespar) 10 mg. Αρχικώς, χορηγούνται 5 mg x 3 (po), ημερησίως, με σταδιακή αύξηση έως 45 mg ημερησίως, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για 15-20 ημέρες.
- Επί συχνών υποτροπών παρόμοιων επεισοδίων, συστήνεται ψυχιατρική εκτίμηση.